doi:10.3969/j.issn.1009-4393.2022.14.027

--论著--

头皮针法联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语患者的临床疗效

朱丽丽
（济宁市市直机关医院中医康复科，山东　济宁　272000）

摘要：目的　探究头皮针法联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语患者的临床疗效。**方法**　选取2019年1月至2020年2月于本院神经内科诊治的104例脑卒中后运动性失语患者作为研究对象，按照随机数字表法分为两组，每组52例。对照组给予常规言语康复治疗，观察组在对照组基础上给予头皮针法治疗，比较两组临床疗效、治疗前后中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）评分、日常生活交流能力量表（CADL）评分及美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分。**结果**　观察组治疗总有效率为96.15%，高于对照组的80.77%（$P<0.05$）。治疗后，两组CRRCAE、CADL评分均高于治疗前，且观察组高于对照组（$P<0.05$）。治疗后，两组NIHSS评分均低于治疗前，且观察组低于对照组（$P<0.05$）。**结论**　头皮针法联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语患者的临床疗效显著，有助于促进患者语言功能恢复，改善患者的语言交流能力，促进神经功能修复，值得临床推广应用。

关键词：头皮针法；言语康复；脑卒中；运动性失语；神经功能缺损程度；日常生活交流能力；语言功能

Clinical efficacy of scalp acupuncture combined with speech rehabilitation in the treatment of patients with motor aphasia after stroke

ZHU Lili
(Department of Traditional Chinese Medicine Rehabilitation, Jining City Municipal Government Hospital, Jining, Shandong, 272000, China)

Abstract: Objective To explore the clinical efficacy of scalp acupuncture combined with speech rehabilitation in the treatment of patients with motor aphasia after stroke. Methods A total of 104 patients with motor aphasia after stroke treated in the Department of Neurology in our hospital from January 2019 to February 2020 were selected as the research subjects, and they were divided into two groups according to random number table method, with 52 cases in each group. The control group was treated with conventional speech rehabilitation, and the observation group was treated with scalp acupuncture treatment on the basis of the control group,the clinical efficacy, Chinese Rehabilitation Research Center standard aphasia ex-

折效果显著，能明显改善患者膝关节功能，减轻疼痛应激反应，降低术后并发症发生率。

参考文献

[1] 赵耀伟,谢加兵,王林,等.胫骨平台骨折的分型与治疗进展[J].中国临床医生杂志,2018,46(1):18-21.
[2] 任京天,肖楚凡,王青田,等.全关节镜下治疗后交叉韧带胫骨止点撕脱骨折的临床效果分析[J].河北医科大学学报,2020,41(5):540-544.
[3] 吴孟超，吴在德.外科学(第9版)[M].北京:人民卫生出版社,2018:671-673.
[4] 黄乐春,胡惠民,梁宇翔.膝关节功能评分量表评述[J].中国医药科学,2016,6(13):50-53.
[5] 王攀,黄光斌,胡平,等.关节镜辅助下微创经皮钢板内固定与传统切开复位内固定对胫骨平台骨折患者的疗效观察[J].创伤外科杂志,2019,21(8):615-619.
[6] 陈刚,郑文标,陈滔,等.关节镜下与切开复位内固定手术治疗胫骨平台SchatzkerⅢ型骨折血清炎症因子变化对预后的影响[J].中国骨伤,2020,33(3):252-256.
[7] 石武谛,柯雯昙.关节镜下经皮微创钢板内固定术与切开复位内固定术对胫骨平台骨折患者膝关节活动度、疼痛应激和炎性因子的影响比较[J].创伤外科杂志,2019,21(3):201-205.
[8] 叶剑平,陈有芬,曹扬.关节镜辅助微创内固定与切开复位内固定治疗胫骨平台骨折的疗效比较[J].中国骨与关节损伤杂志,2020,35(6):631-632.
[9] 余金胜,方文广,冼树强.关节镜辅助下治疗复杂胫骨平台骨折的疗效分析[J].中国内镜杂志,2021,27(3):59-65.
[10] 何小勇.关节镜辅助下微创内固定系统治疗胫骨平台骨折的临床疗效[J].中华全科医学,2017,15(7):1169-1171.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

amination (CRRCAE) score,daily life communication ability scale (CADL) score and National Institutes of Health stroke scale (NIHSS) score of the two group were compared before and after treatment. Results The total effective rate of the observation group was 96.15%, which was higher than 80.77% of the control group ($P<0.05$). After treatment, the CRRCAE and CADL scores of the two groups were higher than those before treatment, and the observation group was higher than that of the control group ($P<0.05$). After treatment, the NIHSS score of the two groups was lower than that before treatment, and that of the observation group was lower than that of the control group ($P<0.05$). Conclusion Scalp acupuncture combined with speech rehabilitation has significant clinical efficacy in the treatment of motor aphasia patients after stroke, it helps to promote the recovery of patients' language function, improve patient's language communication ability and promote the repair of their neurological function, and which is worthy of clinical application.

Keywords: Scalp acupuncture; Speech rehabilitation; Stroke; Motor aphasia; Degree of neurological deficit; Communication ability of daily life; Language function

近年来，脑卒中患者越来越多，且多见于中老年人群，其病残率、病死率较高，大部分患者伴有不同程度后遗症，严重影响其日常生活[1-2]。运动性失语是脑卒中的常见后遗症之一，30%～38%的脑卒中患者伴有运动性失语症，主要表现为非流利性自发谈话、少语、说话费力、言语匮乏、复述困难等。现代医学指出，左大脑动脉上支闭塞是引起运动性失语的主要原因，早期干预对于促进语言功能和神经功能恢复具有重要意义[3-4]。言语康复治疗是目前治疗运动性失语的主要方式，但存在疗程长、费用高、疗效不稳定等缺点。近年来，随着中医学的发展，研究发现中医疗法能改善局部神经血液灌注，促进神经再生，促进神经功能和言语功能恢复[5]。头皮针法是在传统针灸理论上发展起来的一种中医外治疗法，目前已广泛应用于临床，具有操作简单、疗效肯定、针感易接受等优点，患者不仅易接受和坚持治疗，还可最大程度上改善言语功能。基于此，本研究旨在探讨头皮针法联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语患者的临床疗效，现报道如下。

1 资料与方法

1.1　临床资料　选取2019年1月至2020年2月本院神经内科收治的104例脑卒中后运动性失语患者作为研究对象，采用随机数字表法分为两组，每组52例。对照组男30例，女22例；年龄44～76岁，平均（61.1±5.8）岁；病程1～6个月，平均（2.87±0.44）个月；脑梗死39例，脑出血13例；波士顿诊断性失语症检查法（Boston diagnostic aphasia examination，BDAE）分级：Ⅰ级10例，Ⅱ级26例，Ⅲ级14例，Ⅳ级2例。观察组男32例，女20例；年龄42～78岁，平均（61.5±6.0）岁；病程1～7个月，平均（2.94±0.47）个月；脑梗死36例，脑出血16例；BDAE分级：Ⅰ级11例，Ⅱ级23例，Ⅲ级17例，Ⅳ级1例。两组临床资料比较差异无统计学意义，具有可比性。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。

1.2　纳入及排除标准　纳入标准：符合中华医学会制定的《各类脑血管疾病诊断要点》[6]中关于脑卒中诊断标准，为首次发病；经汉语失语症检查表（aphasia battery in Chinese，ABC）法[7]标准诊断为失语症者；脑卒中发病前无明显智力障碍、记忆障碍、听力障碍、视力障碍；年龄40～79岁；生命体征平稳，意识清醒；患者均对本研究知情同意并签署知情同意书。排除标准：蛛网膜下腔出血、腔隙性脑梗死、短暂性脑缺血者；既往有神经系统疾病、智力疾病者；合并心、肝、肾、脑等重要脏器功能障碍者；妊娠期、哺乳期女性；合并听力障碍、严重认知障碍者；对本研究治疗方法不耐受者；未能如期完成疗程者。

1.3　方法　对照组患者给予常规言语康复治疗，由康复科医师与神经内科主治医师配合，了解患者的运动性失语表现、分级等，从而为患者制订个体化的言语康复训练计划，由易到难、由浅入深，循序渐进地开展言语康复训练，主要包括发音器官训练、发音强化练习、词汇练习、命名练习、描述与讲述训练、复述练习等。观察组患者在对照组基础上给予头皮针法治疗，选择健侧言语一区、二区穴位，常规消毒后，用1.5寸毫针，以针尖与头皮呈15°～30°夹角对准进针点快速针刺，刺入头皮穴位后捻转针柄，120 r/min，每个穴位捻转1 min后，连接电针仪（汕头市医用设备厂有限公司，型号：6805-C），留针30 min，频率为10 Hz。每周针刺6 d，休息1 d。两组患者均连续治疗8周。

1.4　观察指标　①语言功能：于治疗前后，采用中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表（Chinese Rehabilitation Research Center standard aphasia examination，CRRCAE）评估患者的语言功能，包括评测患者的听理解、复述、说、朗读、阅读5项，由于本研究中部分患者伴有利手侧肢体偏瘫，故省去抄写、描写、听写检查，每项最高分为10分，最低分0分，总分50分，评分越高表示患者的综合语言功能恢复越好。②临床疗效：根据语言功能评分评价临床效果，痊愈为治疗后，语言功能评分≥46分；显效

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为治疗后，语言功能评分较治疗前增加＞20分。进步为治疗后，语言功能评分较治疗前增加3～20分。无效为治疗后，语言功能评分增加＜3分或出现降低情况。总有效率=治愈率+显效率+进步率。③神经功能缺损程度：于治疗前后，使用美国国立卫生研究院卒中量表（National Institutes of Health stroke scale，NIHSS）评估患者的神经功能缺损程度，总分42分，评分越高表明患者神经功能缺损越严重。④日常生活交流能力：于治疗前后，采用日常生活交流能力（communication activity of daily living，CADL）量表评估两组患者日常生活交流能力，该量表共包含68项日常生活中常见的每日言语活动，总分136分，评分越高表明患者的日常交流能力越好。

1.5　统计学方法　采用SPSS 24.0统计学软件分析数据，计数资料以[n(%)]表示，行χ^2检验，计量数据以“$\bar{x}\pm s$”表示，行t检验，以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1　两组临床疗效比较　观察组治疗总有效率为96.15%，高于对照组的80.77%，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表1。

表1　两组临床疗效比较[n(%)]

Table 1 Comparison of clinical efficacy between the two groups [n(%)]

组别	例数	痊愈	显效	进步	无效	总有效率
观察组	52	12（23.08）	24（46.15）	14（26.92）	2（3.85）	50（96.15）
对照组	52	8（15.38）	20（38.46）	14（26.92）	10（19.23）	42（80.77）
χ^2值						6.029
P值						0.014

2.2　两组治疗前后CRRCAE、CADL评分比较　治疗前，两组CRRCAE评分及CADL评分比较差异无统计学意义；治疗后，两组CRRCAE评分及CADL评分均高于治疗前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表2。

表2　两组治疗前后CRRCAE、CADL评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

Table 2 Comparison of CRRCAE and CADL scores before and after treatment between the two groups ($\bar{x}\pm s$, scores)

组别	例数	CRRCAE评分		CADL评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	52	19.4±2.3	42.1±4.3[a]	47.3±4.6	98.4±8.3[a]
对照组	52	19.8±2.9	33.7±3.8[a]	47.9±4.5	73.2±6.5[a]
t值		0.779	10.556	0.672	17.237
P值		0.438	＜0.05	0.503	＜0.05

注：CRRCAE，中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表；CADL，日常生活交流能力量表。与本组治疗前比较，[a]$P<0.05$

2.3　两组治疗前后NIHSS评分比较　治疗前，两组NIHSS评分比较差异无统计学意义；治疗后，两组NIHSS评分均低于治疗前，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表3。

表3　两组治疗前后NIHSS评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

Table 3 Comparison of NIHSS scores between the two groups before and after treatment ($\bar{x}\pm s$, scores)

组别	例数	治疗前	治疗后	t值	P值
观察组	52	19.1±2.3	5.2±0.5	42.585	＜0.05
对照组	52	18.5±2.1	9.5±1.1	27.072	＜0.05
t值		1.389	25.662		
P值		0.168	＜0.05		

3 讨论

言语是人大脑所独有的功能，是人们进行思想交流的重要工具。脑卒中后的失语症以运动性失语为主，以口语表达障碍为主要特点，伴有语言复述、物品命名、文字书写等方面的障碍。病变首先累及优势半球Broca区，构音肌功能正常，但言语表达能力缺失或只能说出个别单字，无法完成文字复述、书写[8]。脑卒中后运动性失语症患者与医护人员、家属等交流困难，甚至丧失社会交往能力，严重影响患者的日常生活和康复治疗效果。现代康复医学认为，早期康复训练有助于促进患者语言功能恢复，但是康复治疗疗程长、费用高，且疗效不稳定[9]。为此，探寻更为安全有效的治疗方法具有重要意义。

近年来，越来越多的学者探索中医疗法在脑卒中后运动性失语中的治疗效果，卢英等[10]研究认为，针灸与中药口服应用于脑卒中后运动性失语患者中，能促进患者语言功能改善，改善血液流变学，疗效优于单一应用言语康复训练的患者。罗艳[11]研究指出，针灸与言语康复训练联合使用能促进患者语言功能和神经功能修复。祖国医学认为，脑卒中后运动性失语可归属于“暗痱”“风懿”等范畴，认为该病的发病原因为心脾肝肾等脏腑受风、痰、瘀、火等所伤，以至于心肾经络受阻，从而扰乱神明、阻滞舌窍，导致失语症状[12-13]。因此，在治疗中需以固本为主，注重气血调合，兼顾化瘀、开窍、豁痰等。本研究结果显示，观察组治疗总有效率高于对照组（$P<0.05$）；治疗后，两组CRRCAE、CADL评分均高于治疗前，NIHSS评分均低于治疗前，且观察组CRRCAE、CADL评分均高于对照组，NIHSS评分低于对照组（$P<0.05$）。分析原因为，头是脏腑经络之血汇聚之所，头部的经穴与语言功能密切相关[14]，故针刺头皮特定穴位能起到疏通经络、活血化瘀、醒脑开窍、调节脏腑阴阳的作用。参照焦氏头针的大脑皮层定位理论依据，选择健侧言语一

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

doi:10.3969/j.issn.1009-4393.2022.14.028

--论著--

复方桐叶烧伤油在大面积烧伤残余创面中的应用价值

温珍华，黄爱萍，刘琴，刘少良
（新钢中心医院烧伤科，江西　新余　338000）

摘要：目的　探讨复方桐叶烧伤油在大面积烧伤残余创面中的应用价值。**方法**　选取2018年5月至2020年9月本院收治的60例大面积烧伤残余创面患者作为研究对象，按照随机数字表法分为对照组和观察组，每组30例。对照组给予利福平胶囊粉剂治疗，观察组给予复方桐叶烧伤油治疗，比较两组临床疗效、治疗2周后创面细菌阴转率、临床指标（疼痛评分、创面愈合时间、住院时间）。**结果**　观察组治疗总有效率（96.67%）高于对照组（73.33%），差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗2周后，观察组创面细菌阴转率（66.67%）高于对照组（36.67%），差异有统计学意义（$P<0.05$）。观察组疼痛评分低于对照组，创面愈合时间、住院时间均短于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论**　复方桐叶烧伤油应于大面积烧伤残余创面患者，可显著改善其临床症状，减轻患者疼痛，提高细菌阴转率，促进创面早期愈合，疗效显著，值得临床推广应用。

关键词：复方桐叶烧伤油；大面积烧伤；残余创面；细菌阴转率

Application value of compound Tung leaf burn oil in large-area burn residual wound

WEN Zhenhua, HUANG Aiping, LIU Qin, LIU Shaoliang
(Department of burn, XinSteel Central Hospital, Xinyu, Jiangxi, 338000, China)

Abstract: Objective To explore the application value of compound Tung leaf burn oil in large area burn residual wound. Methods 60 patients with large-area burn residual wounds treated in our hospital from May 2018 to September 2020 were selected as the research subjects, and they were

区和二区穴位，与卒中后运动性失语患者的受损大脑功能区相对应，通过针刺该部位的头皮穴位能起到调节“皮层-丘脑-皮层”的效果，改善患者语言功能中枢附近的血液循环，促进患者言语功能及神经通路的重建，进而促进言语功能恢复及神经功能修复，改善患者的日常活动交流能力[15]。

综上所述，头皮针法联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语患者效果确切，有助于促进患者语言功能恢复及神经功能修复，改善患者的日常活动交流能力，值得临床推广应用。

参考文献

[1] 白俊敏,闫秀丽,吴明莉,等.互动式头针治疗中风后运动性失语的临床疗效[J].时珍国医国药,2017,28(6):1394-1396.
[2] 杨娅,刘广霞,徐洋,等.针刺“开瘖五穴”结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语临床观察[J].安徽中医药大学学报,2019,38(2):48-51.
[3] 张若萌,孙善斌.头皮针联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语[J].长春中医药大学学报,2020,36(2):339-342.
[4] 程熙,赖靖慧,王志峰,等.带针下言语训练对脑卒中后运动性失语的疗效观察[J].亚太传统医药,2018,14(8):153-154.
[5] 位文佩,张华,常静玲,等.益髓醒神法针刺联合语言康复对卒中后失语患者脑白质微观结构的影响[J].现代中西医结合杂志,2021,30(35):3877-3883.
[6] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经精神杂志,1998,21(61):60.
[7] 李胜利,肖兰,田鸿,等.汉语标准失语症检查法的编制与常模[J].中国康复理论与实践,2000,6(4):162-164,封三
[8] 浦建能,党宝齐,袁媛,等.针药并用联合康复治疗对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(15):1665-1667,1677.
[9] 程秀宇,吕岩峰,张虹,等.康复结合头针、放血对老年脑卒中后言语功能障碍患者的疗效[J].中国老年学杂志,2019,39(8):1821-1823.
[10] 卢英,廖炼炼,梁辉.针药并用联合康复训练对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能及血液流变学的影响[J].湖南中医药大学学报,2019,39(9):1138-1142.
[11] 罗艳.针灸联合康复治疗脑卒中后运动性失语的临床效果及对NIHSS评分的影响观察[J].当代医学,2018,24(34):150-152.
[12] 杨玲,郭耀光.头电针配合言语训练治疗脑卒中后失语的临床研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(3):305-308,312.
[13] 金荣祥,张成,倪红雷,等.头针联合语言康复训练对脑卒中后运动性失语症患者的疗效研究[J].新疆医科大学学报,2018,41(12):1503-1507.
[14] 赖新生,黄泳.经穴—脑相关假说指导下经穴特异性、针刺得气、配伍规律脑功能界定[J].中国针灸,2007,27(10):777-780.
[15] 闵友江,姚海华,邵水金,等.浅析《头针穴名国际标准化方案》的科学性[J].中国针灸,2007,27(8):612-616.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net